

Restrukturyzacja *obron*

Sekwencja ISTDP: identyfikacja → klaryfikacja → wyzwanie → presja. Terapeuta i pacjent są sojusznikami, a obrona jest trzecią stroną, która ich rozdziela. Wymaga szkolenia.

CZAS: 45 min · poziom zaawansowany Sesje 2–15; gdy obrona blokuje dostęp do afektu

ŹRÓDŁO: Davanloo (1990); Abbass (2015)

JAK UŻYWAĆ

Stosujesz systematyczną sekwencję pracy z obroną. **Identyfikacja:** dostrzegasz obronę w czasie rzeczywistym. **Klaryfikacja:** nazywasz ją zrozumiale („gdy dotykamy emocji, przechodzi Pani do teorii”). **Wyzwanie** (ang. *challenge*): zapraszasz do odejścia od obrony („co Pani odczuwa teraz w ciele, nie w głowie?”). **Presja** (ang. *pressure*): utrzymujesz fokus mimo oporu („zostańmy przy uczuciu jeszcze chwilę”).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Zbyt wczesna konfrontacja rani i wywołuje opór; brak konfrontacji nie daje zmiany. Cel sekwencji to przerwanie automatycznej obrony i otwarcie przestrzeni na doświadczenie afektu. Kluczowe: technikę stosuje się **w sojuszu** — nie jako atak, lecz współpracę przeciwko obronie. Precyzyjna restrukturyzacja przewiduje większość wariacji w efektach ISTDP (Abbass i Town, 2013). Uwaga etyczna: niewłaściwie zastosowana powoduje regresję i pęknięcia sojuszu — wymaga szkolenia i superwizji.

01



Sekwencja czterech kroków

- ① **Identyfikacja** — „gdy zapytałem o matkę, zaczęła Pani mówić o pogodzie” (obserwacja)
- ② **Klaryfikacja** — „czy zauważa Pani to przesunięcie? Coś w pytaniu było niewygodne?”
- ③ **Wyzwanie** — „czy moglibyśmy wrócić? Co pojawiło się, gdy usłyszała Pani 'matka'?”
- ④ **Presja** — „znów jest pokusa teoretyzowania — zostańmy z uczuciem. Co się pojawia?”

02



Przygotuj sekwencję dla tej obrony

Wybierz jedną obronę pacjenta i rozpisz cztery kroki konkretnym językiem — to pomaga utrzymać delikatność i kierunek.

MOJA SEKWENCJA (IDENTYFIKACJA → KLARYFIKACJA → WYZWANIE → PRESJA)

03 ✱ Rozpoznaj kontakt z afektem

Sygnały, że obrona się rozluźnia: łzy, zmiana oddechu, zmiana tonu głosu, ciepło w twarzy, spontaniczna cisza. Gdy afekt się pojawia — **zatrzymaj technikę i bądź z pacjentem**. Nie interpretuj w tym momencie; afekt wymaga przestrzeni, nie słów.

SYGNAŁY KONTAKTU Z AFEKTEM U TEGO PACJENTA

04 ✕ Granica bezpieczeństwa

Jeśli pacjent doświadcza techniki jako ataku — zrób krok wstecz i wzmacniaj sojusz. Nie stosuj sekwencji bez szkolenia ISTDP i superwizji. Zapisz, kiedy odpuścisz presję u tego pacjenta.

SYGNAŁ, ŻE TRZEBA ODPUŚCIĆ I WRÓCIĆ DO SOJUSZU

Klucz: „presja” nie oznacza naciskania emocjonalnego — oznacza delikatne utrzymanie fokusu mimo pokusy ucieczki. To obecność, nie agresja. Celem zawsze jest współpraca, nie kontrola: terapeuta i pacjent są sojusznikami przeciwko obronie.